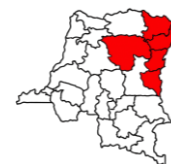




TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°106/MVEBDB/28/08/2026

Date de rapportage : 28 août 2026

Date de publication : 29 août 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

En date du 28 août 2026, 82 nouveaux cas confirmés dont 24 décès communautaires de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été enregistrés dans les provinces de l'Ituri (66 cas), du Nord-Kivu (12 cas), Haut Uélé (4). De plus, 14 décès intra-CTE ont été enregistrés.

Aucune nouvelle zone de santé touchée au cours de dernières 24h.

CUMUL DES CAS 5 945	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS 2 862	LETALITE 48,1%	PATIENS EN ISOLEMENT/CTE 896	CUMUL DES GUÉRIS 1 327	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour) 84,4 %
--	--	-------------------------------------	---	---	--



Provinces touchées et Zones de santé touchées



6 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



60 Zones de santé touchées sur 151

(39,7%)



Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures

Pour la journée du 28 août 2026, **82 nouveaux cas confirmés** dont **24 décès communautaires** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été rapportés dans les provinces de l'Ituri (66 cas), Nord-Kivu (12), Haut Uélé (4).

D'autre part, **9 patients** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE (8 en Ituri et 1 au Nord Kivu). De plus, **14 décès intra-CTE** ont été enregistrés, dont 10 en Ituri, 2 au Haut Uélé, 1 au Bas Uélé et 1 au Nord-Kivu. Ce qui porte **le nombre des décès du jour à 38**.

Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 28 août 2026, **5 945 cas confirmés** dont **2 862 décès** ont été rapportés en RDC, soit une létalité de **48,1 %**. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant **82,6 %** des cas confirmés cumulés et **80,5 %** des nouveaux cas rapportés.

Globalement, 60 des 151 (39,7%) zones de santé des six provinces restent affectées depuis le début de l'épidémie en RDC. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (15/34) du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) et Bas Uélé (3/11).

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 28 août 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	66	4911	2 212	45,0%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	12	800	546	68,3%	15/34 (44,1 %)
Haut-Uélé	4	209	93	44,5%	6/13 (46,1 %)
Tshopo	0	19	8	42,1%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas Uélé	0	3	2	66,7%	3/11(27,3%)
Total	82	5 945	2 862	48,1%	60/151 (39,7%)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone de santé, au 28 août 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	4911	2212	45,0%	66	17	10	27
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%	1	0		0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	157	35	22,3%	1	1		1
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1375	430	31,3%	28	6		6
Damas	27	9	33,3%				0
Drodro	13	6	46,2%				0
Fataki	74	30	40,5%				0
Gethy	6	2	33,3%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	32	12	37,5%				0
Komanda	72	48	66,7%	3	2		2
Lita	210	111	52,9%	2	0		0
Logo	11	5	45,5%				0
Lolwa	19	4	21,1%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	17	7	41,2%				0
Mandima	36	21	58,3%	3	2		2
Mangala	227	117	51,5%	14	3		3
Mongbwalu	608	285	46,9%	2	1		1
Nia-Nia	205	108	52,7%	2	0		0
Nizi	646	258	39,9%	6	2		2
Nyankunde	124	35	28,2%				0
Rimba	10	4	40,0%				0

Rwampara	939	336	35,8%	4	0		0
Tchomia	56	25	44,6%				0
A ventiler**	NA	307	NA	NA	NA	10	10
Nord-Kivu	800	546	68,3%	12	7	1	8
Beni	128	93	72,7%	2	1	1	2
Biena	1	1	100,0%				0
Butembo	160	121	75,6%	5	3	0	3
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	16	7	43,8%				0
Katwa	377	253	67,1%	4	3	0	3
Kyondo	16	12	75,0%				0
Lubero	1	1	100,0%				0
Mabalako	3	2	66,7%				0
Manguredjipa	1	0	0,0%				0
Masereka	8	4	50,0%				0
Musienene	75	43	57,3%	1	0	0	0
Mutwanga	1	1	100,0%				0
Oicha	7	6	85,7%				0
Vuhovi	5	2	40,0%				0
Haut-Uélé	209	93	44,5%	4	0	2	2
Boma Mangbetu	26	14	53,8%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	79	33	41,8%				0
Pawa	24	16	66,7%				0
Rungu	1	0	0,0%				0
Wamba	76	29	38,2%	4	0	2	2
Tshopo	19	8	42,1%	0	0	0	0
Bafwasende	2	0	0,0%				0
Kabondo	3	1	33,3%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	9	4	44,4%				0
Mangobo	2	2	100,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	3	2	66,7%	0	0	1	1
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	1	0	0,0%				0
Ganga	1	1	100,0%	0	0	1	1
Total	5945	2862	48,1%	82	24	14	38

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifié par zone de santé.
NA : Non Applicable.

** Ces décès ont été enregistrés dans les différents CTE de la province de l'Ituri et sont en cours de ventilation.

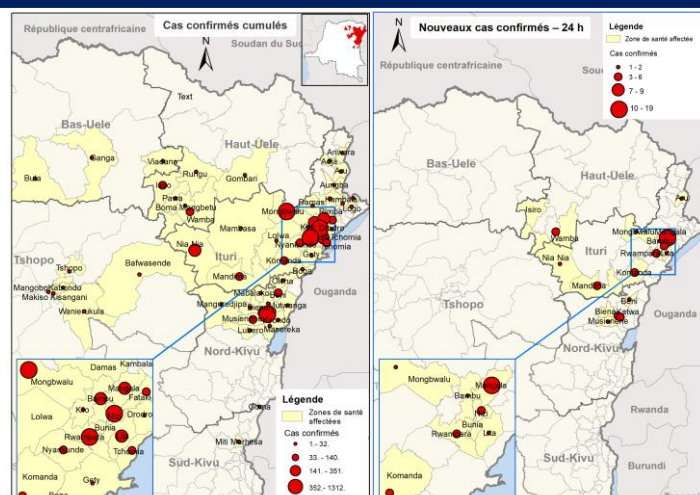
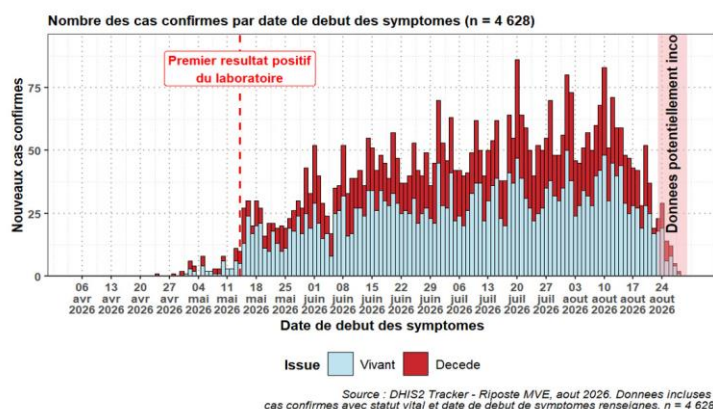
Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province, au 28 août 2026

DPS	Nouvelles Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	14	2	16	12	2	1	0	14	12
Bas Uélé	14	4	18	2	3	12	1	5	0
Ituri	852	81	933	175	71	351	8	246	141
Nord-Kivu	885	34	919	95	34	733	0	129	95
Sud-Kivu	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tshopo	138	1	139	1	0	137	1	1	0
Total Général	1903	122	2 025	285	110	1234	10	395	248

ND : Non disponible.

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours

Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24h et cumulés) par zone de santé.



1. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

1.1.Coordination

1.1.1. Principales Actions

- Suivi et accompagnement des actions de la réponse dans toutes les provinces touchées.

1.1.2. Surveillance épidémiologique

1.1.3. Principales Actions

En date du 28 août 2026, 2 025 alertes ont été enregistrées, dont 1 639 (80,9%) ont été vérifiées dans les 6 provinces touchées. Ainsi, 395 (24,1 %) ont été validées comme cas suspects et tous ont été investigués, soit 100,0 %, desquels 248 ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

Au cours des dernières 24 heures, la proportion des contacts suivis se situe à 84,4 % (21 109 vus sur 25 015 à suivre), proche du seuil de 85 % : Ituri 87,1 % (11 956/13 734), Tshopo 100% (413/413), Nord-Kivu 81,4 % (7 339/9 019), Haut Uélé 78,6% (1 220/1 552) et Bas Uélé 60,9% (181/297).

1.1.4. Défis

Persistance d'un faible suivi des contacts autour des cas confirmés dans les provinces du Bas et Haut Uélé, lié à une insuffisance des équipes dédiées à ces activités.

1.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

1.2.1. Principales actions

- Onze (11) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours des dernières 24 heures : deux en Ituri au PoC Zunguluka (ZS Mambasa), validées, isolées et référées à l'HGR Mambasa ; sept au Nord-Kivu, dont deux validées et référées ; deux au Bas-Uélé, l'une au PoC PK15 Balé (ZS Buta) portant sur un corps sans vie, validée et swabée, l'autre au PoC PK12 Isiro (ZS Viadana), invalidée après investigation.

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Bas-Uélé	Global
Complétude des rapports	95 % (57/60)	100 % (18/18)	55,5 % (5/9)	100 % (7/7)	64 % (7/11)	60 % (12/20)	84,8 % (106/125)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	9,09 % (1/11)	100 %	NA	35 % (7/20)	64 % (7/11)	ND	ND
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	144 215	87 429	7 567	7 305	13 022	4 140	263 678
% des voyageurs screenés	97,7 %	98,0 %	98,0 %	99,0 %	96,0 %	ND	97,8 %
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,7 %	98,0 %	98,0 %	99,0 %	96,0 %	ND	97,8 %
% des voyageurs sensibilisés	99,5 %	98,0 %	100 %	100 %	99,0 %	ND	99,0 %
Nombre d'alertes notifiées	2	7	0	0	0	2	11
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	2	2	0	0	0	0	4
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0	0	1	1
% des cas suspects transférés au CT/CTE	100 % (2/2)	100 % (2/2)	0 %	0 %	0 %	NA	100 % (4/4)
% des corps sans vie swabés/sécurisés	0 % (0/0)	0 % (0/0)	0 %	0 %	0 %	100 % (1/1)	100 % (1/1)
% des cas suspects investigués dans 24 h	100 % (2/2)	100 % (2/2)	0 %	0 %	0 %	100 % (2/2)	100 % (6/6)

1.2.2. Défis

Opérationnalisation insuffisante des PoE/PoC : la complétude globale se situe à 84,8 % (106 rapports sur 125), avec des niveaux faibles au Sud-Kivu (55,5 %), au Bas-Uélé (60 %) et au Haut-Uélé (64 %). En Ituri, 1 (9,09 %) des 11 PoE/PoC stratégiques fonctionne sans interruption et le PoC d'Avakubi reste non fonctionnel pour raisons sécuritaires. Au Haut-Uélé, 4 PoC (Dusu, Apodo, PK6 route Niangara et Aungba) n'ont pas transmis leurs données.

1.3. Laboratoire

1.3.1. Principales actions

- Ituri : 66 nouveaux résultats positifs** (49 vivants et 17 décès) sur 358 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 18,4 %**).
- Tshopo** : 5 échantillons ont été reçus dont 1 swab analyse, tous revenus négatifs.
- Nord-Kivu : 12 nouveaux résultats positifs** (5 vivants et 7 décès) sur 185 échantillons analysés (**positivité de 6,5%**).

- **Haut-Uélé : 4 nouveaux résultats positifs** (4 vivants) sur 23 échantillons analysés (positivité est de 17,4%).
- **Bas-Uélé : 2 échantillons (swabs) reçus et testés à Buta, aucun résultat positif.**

1.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

1.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 29 rings ont été ouverts sur les 33 identifiés (87,9 %), 122 ménages décontaminés sur 182 identifiés (67,0 %) et 7 FOSA sur 7 (100 %) ; aucun kit n'a été doté aux ménages et 4 évaluations de FOSA ont été réalisées.
- **À la Tshopo**, Suivi et accompagnement de 15 ESS dans 5 ZS (Makiso-Kisangani, Mangobo, Tshopo, Kabondo et Lubunga) au cours desquels 149 prestataires ont été briéféés sur la mise en œuvre des mesures PCI ; décontamination de 13 locaux de la Polyclinique ART et évaluation des risques de 4 prestataires.

1.4.2. Défis

- Faible mise en œuvre des normes de PCI : en Ituri, la décontamination des ménages reste limitée à 67,0 % et aucun kit PCI n'a été doté ; insuffisance d'équipes de décontamination à Fataki, Mangala et Nizi et manque de mobilité à Komanda, Bambu, Mandima et Mangala.
- À la Tshopo, insuffisance d'EPI dans les ESS, prestataires non formés et panne de l'incinérateur de l'HGR Makiso-Kisangani.

1.5. Continuité des soins

1.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 113 nouvelles admissions ont été enregistrées et 97 sorties dont 8 guéris. Ainsi, 552 patients sont hospitalisés pour 978 lits, soit un taux d'occupation de 56,4 %.
- **Au Nord-Kivu**, 75 admissions ont été enregistrées contre 64 sorties dont 1 guéri. Au décours de la journée, 236 patients sont hospitalisés pour 220 lits, soit un taux d'occupation de 107,3 %.
- **Au Bas Uélé**, 1 patient confirmé est en cours de soins pour 3 lits disponibles (Taux d'occupation : 33,3 %)
- **Au Haut Uélé**, 11 nouvelles admissions de cas suspects ont été enregistrées et 7 sorties, 70 patients sont hospitalisés pour 120 lits, soit un taux d'occupation de 58,3 % ;
- **À la Tshopo**, 3 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 4 sorties et 11 patients sont en isolement pour 25 lits, soit un taux d'occupation global de 44,0%.
- **Au Sud-Kivu**, 26 patients restent en isolement.

1.5.2. Défis

Faible capacité d'accueil et absence de CTE dans certaines zones de santé : dépassement de la capacité au Nord-Kivu (107,3 %), où une partie des suspects est isolée dans des ESS qui ne sont pas des centres de traitement ; au Bas-Uélé, absence de CTE aux normes et de partenaire d'appui à la prise en charge.

1.6. Communication sur les risques et engagement communautaire

1.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 218 personnes ont été touchées autour des 9 derniers cas confirmés (72 à Rwampara, 76 à Lolwa, 38 à Rwampara/Shari, 12 à Nyankunde et 20 à Rwampara/Tchunga) ; 385 personnes sensibilisées lors d'un dialogue communautaire suivi d'une caravane motorisée aux villages Miala et Solenyama ; 8 EDS facilitées et 9 ménages

décontaminés à Rwampara ; 90 contacts listés à Rwampara et 99 à Lolwa avec l'appui de la CREC.

- **À la Tshopo**, sensibilisation des PPL des établissements de soins de Makiso-Kisangani, 3 émissions radiodiffusées animées et diffusion de spots sur quatre radios ; 3 rumeurs clarifiées.
- **Au Nord-Kivu**, communication de proximité autour de 16 cas confirmés et 68 chefs de ménage touchés (Butembo 5 cas/17 ménages, Oicha 4/13, Lubero 2/14, Kyondo 1/9, Kalunguta 1/6, Katwa 1/4, Beni 1/3 et Vuhovi 1/2) ; briefing de 457 chefs d'établissements scolaires en prélude à la rentrée et 11 rumeurs clarifiées.
- **Au Haut-Uélé**, accompagnement d'une famille endeuillée à Neisu (ZS Isiro) ; 15 annonces de résultats réalisées (11 à Isiro et 4 à Pawa) dont 4 positives ; 46 accompagnants et 21 PPL ont été soutenus ; Suivi du déchargement de 3 patients déjà déclarés guéris à Pawa et suivi du déchargement de 13 guéris à Wamba.

1.6.2. Défis

Persistance des défis au niveau communautaire : en Ituri, refus d'isolement d'un suspect à Nia-Nia, refus EDS dans la ZS de Lolwa (AS Elake) ;

1.7. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

1.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 19 personnes ont bénéficié d'interventions SMSPS autour des derniers cas confirmés (Bunia 8, Rwampara 5, Nizi 3, Lita 2 et Komanda 1).
- **Au Nord-Kivu**, 25 des 55 nouveaux cas confirmés et suspects ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 86 annonces de résultats sur 102 ont été réalisées dont 25 positives, 62 ménages accompagnés, 98 PPL soutenus, 5 enfants suivis en communauté et 2 guéris réinsérés sur 4 (50 %) ; les 4 ZS ayant notifié sont couvertes (100 %).
- **Au Haut-Uélé**, accompagnement psychologique d'une famille endeuillée à Neisu (ZS Isiro) ; 15 résultats de laboratoire annoncés (11 à Isiro et 4 à Pawa) dont 4 positifs ; 46 accompagnants et 21 PPL appuyés.

1.7.2. Défis

- **Au Haut Uélé**, couverture SMSPS insuffisante. **Au Nord-Kivu**, seules 4 ZS sont couvertes par des interventions autour des derniers cas et les crèches font défaut dans les CTE. **En Ituri**, aucune couverture à Bambu, Nia-Nia, Mambasa et Lolwa, la couverture reste limitée à 5 des 11 ZS ayant notifié (45 %).

1.8. Logistique

1.8.1. Principales actions

Dans la Tshopo, réception d'un premier lot de médicaments MVE (appui Enabel), livraison de kits en appui à la vaccination et suivi de la construction des sites d'isolement (Madula, Kabondo et Konga-Konga) et du CTE de grande capacité.

Au Nord-Kivu, fin des travaux d'érection du CTE de Musienene, poursuite de la toiture et du cloisonnement du CTE de Matanda, et approvisionnement en médicaments et intrants des ZS nouvellement affectées de Manguredjipa et Biena.

1.9. Sécurité

1.9.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, couverture sécuritaire des équipes PCI dans les AS de Butsili, Mdrandele et Kanzunzulili ainsi qu'au CS Nyakunde ; accompagnement de l'équipe EDS au cimetière de Bundji pour l'enterrement de 4 corps de cas confirmés et pour des swabs au CH Peregrin et au CH Don Divin ; supervision et évaluation sécuritaire au PoE Kyaghala et au PoC Kitakandi.

1.9.2. Défis

La sécurisation des PoC stratégiques reste incomplète : au Haut-Uélé, le corps sans vie intercepté au PoC de Magambe (ZS Isiro) a été relâché par la sécurité sans avoir pu être swabé. Au Nord-Kivu, l'insécurité persiste dans les zones d'enterrement et la route menant au cimetière de Bundji (ZS de Beni) reste impraticable.

1.10. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

1.10.1. Principales actions.

En Ituri, poursuite de la sensibilisation à la PSEAH auprès des équipes de riposte et des communautés autour des derniers cas confirmés, ainsi que de l'affichage des messages et de la distribution de dépliants dans les ZS de Bunia, Aru, Rwampara et Mongbwalu ; à la Tshopo, intégration des messages PSEAH dans les séances de sensibilisation des PPL des établissements de soins de Makiso-Kisangani.

1.10.2. Défis

- Couverture encore insuffisante des activités PSEA : 25 % des zones de santé de l'Ituri (9/36) connaissent le mécanisme de signalement et seuls 2 partenaires (OMS et IMC) rapportent leurs activités PSEA ; absence de cartographie des intervenants ; insuffisance de supports de sensibilisation de masse ; manque de moyens de transport et d'équipement informatique pour le pilier.

MESSAGES CLES

- La transmission de la MVE reste active, avec 82 nouveaux cas dont 24 décès communautaires et 14 intra- CTE enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le cumul national à 5 945 cas confirmés et 2 862 décès.
- L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 82,6 % des cas confirmés cumulés et 80,5% des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures et une expansion plus importante (28 des 36 ZS affectées).
- La surveillance affiche une bonne performance (100%) des cas suspects investigués tandis que le taux de suivi (84,4%) proche du seuil de 85,0%.
- Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel pour interrompre rapidement les chaînes de transmission.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr Kombe NGWAMA John

Equipe rédaction

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard

Dr Katusi Biselenge Jules

Madame Mayele Afua Marie

Dr Diur Mananashi Floryan

Mr Kamuina Kebela John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd